

Visione di Progetto — Salute Quotidiana

Prefazione: il sistema che ci è stato consegnato

Ci hanno cresciuti con un'idea di fondo: che la natura sia competizione, che il più forte sopravviva, che l'interesse personale sia il motore di tutto. Questa idea non è rimasta in biologia. È diventata il fondamento dell'economia, della politica, del modo in cui organizziamo la società intera. Se vince il più forte, allora è giusto che i mercati finanziari comandino. Se la competizione è legge di natura, allora è giusto che chi non ce la fa... non ce la fa. Punto.

Peccato che il modello socio-economico dentro il quale siamo stati immersi — e per il quale tutti i giorni della nostra vita siamo costretti a combattere più del dovuto — è un modello studiato a tavolino: fatto per far passare come regole valide per tutti quelle che in realtà sono regole costruite con un unico scopo, l'arricchimento di pochi a discapito della maggior parte della popolazione.

E così, nel corso dei decenni, abbiamo visto costruire un sistema economico — attraverso trattati, istituzioni, regole scritte lontano dai cittadini — in cui il denaro non è uno strumento al servizio delle persone, ma il fine per cui le persone esistono. Le banche centrali rispondono ai mercati, non ai cittadini. I governi tagliano sanità e servizi sociali non perché vogliono, ma perché "i conti devono tornare". La salute diventa un mercato. L'anziano che non può permettersi l'infermiere a domicilio è un "costo sociale", non una persona con diritti.

Tutto questo ha una logica interna coerente: se siamo animali competitivi, se il valore di un essere umano si misura in produttività economica, allora chi è malato, vecchio, fragile vale meno. Non lo dice nessuno apertamente. Ma lo dice il sistema ogni giorno, con ogni scelta che fa, con ogni fondo tagliato, con ogni lista d'attesa che si allunga.

Io questa cosa non riesco ad accettarla.

L'ideologia di Salute Quotidiana: un'interruzione consapevole

Salute Quotidiana nasce da una convinzione semplice: l'uomo non è fatto per competere fino alla morte, è fatto per stare in comunità. La cooperazione non è debolezza, è l'istinto più antico e profondo che abbiamo. Prima di qualsiasi trattato internazionale, prima di qualsiasi mercato finanziario, c'era il vicino che aiutava il vicino. Il commerciante che si fidava del cliente. L'infermiere che andava a casa perché era la cosa giusta da fare, non perché c'era un profitto da estrarre.

Il sistema che ci è stato consegnato ci ha convinto che questo sia ingenuo. Che il buon senso sia la competizione. Che chi si fida perda. Che la solidarietà sia un lusso che non ci possiamo permettere.

Io non voglio combattere questo sistema con la politica o con le parole. Voglio dimostrare, con fatti concreti e locali, che un modello diverso funziona. Che un esercizio commerciale può fare marketing senza spendere soldi in gadget inutili e invece costruire qualcosa di realmente utile per la comunità in cui

lavora. Che un cliente può fare la spesa al bar sotto casa e — senza spendere un centesimo in più — contribuire a creare un fondo che un giorno lo aiuta a curarsi.

È una cosa piccola. Lo so. Ma le risposte vere ai sistemi sbagliati partono sempre da cose piccole e concrete, non da manifesti. E questa è la mia risposta.

Il progetto: Credito Salute SQ

Come nasce l'idea

Faccio l'infermiere. Lavoro sul territorio, vado a casa delle persone. E vedo ogni giorno due realtà che non comunicano tra loro.

Da un lato, famiglie che hanno bisogno di cure a domicilio — una medicazione, un prelievo, la gestione di un presidio sanitario — ma che rimandano, rinunciano, si arrangiano perché la prestazione costa e non è sempre la priorità nel bilancio familiare. Non stiamo parlando di cose superflue. Stiamo parlando di salute concreta, di ferite che vanno curate, di analisi che vanno fatte, di procedure che richiedono un professionista e non un parente con buona volontà.

Dall'altro lato, esercizi commerciali — bar, negozi, attività locali — che spendono ogni anno soldi in pubblicità che non funziona. Volantini che finiscono nel cestino. Gadget che nessuno ricorda. Promozioni che non portano clienti nuovi e non fidelizzano quelli vecchi. Denaro che evapora senza lasciare traccia né nel portafoglio del commerciante né nella vita di nessuno.

E io mi sono chiesto: c'è un modo per mettere insieme queste due cose? Per fare in modo che il denaro che un commerciante già spende in marketing — e che attualmente non produce niente di utile — torni invece a vantaggio della comunità in cui quel commerciante lavora ogni giorno?

La risposta è Credito Salute SQ.

Come funziona, passo per passo

Partiamo dall'esercizio commerciale. Il titolare — chiamiamolo Giovanni, ha un bar — ogni mese destina una parte del suo budget promozionale a un fondo gestito da Salute Quotidiana. Non è una donazione, non è beneficenza, non è un'opera pia. È una campagna promozionale con un ritorno concreto e misurabile: i suoi clienti abituali vengono fidelizzati, tornano, e il suo bar diventa il posto del quartiere "che pensa alle persone".

Ogni volta che un cliente fa una consumazione al bar di Giovanni, accumula il 15% della spesa sotto forma di Credito SQ. Un caffè da 1,50€ genera 0,22€ di credito. Nel tempo, il credito si accumula silenziosamente, senza che il cliente debba fare niente di speciale: basta fare la spesa dove la fa sempre.

E quando quel cliente — o un suo familiare — ha bisogno di un'iniezione a domicilio, di una medicazione, di un prelievo del sangue, può usare il Credito SQ come sconto diretto sulla prestazione infermieristica. Un euro di credito vale un euro di sconto, senza conversioni strane, senza punti, senza scadenze

cervellotiche.

Nessun intermediario. Nessuna assicurazione. Nessuna burocrazia da navigare. Un'app web semplice gestisce tutto in trasparenza: il titolare vede l'andamento del fondo, il cliente controlla il suo saldo, io come Salute Quotidiana registro le prestazioni e tengo i conti puliti.

La solidarietà attiva: cedere e donare il credito

Il Credito SQ non è un saldo che aspetta solo il tuo prelievo o la tua medicazione. Puoi farne quello che vuoi, anche darlo a qualcun altro.

Cessione libera tra persone. Se accumuli crediti ma non ne hai bisogno in questo momento, puoi cederli a chiunque tu voglia: tua madre, il vicino di casa, un amico che sai avere una medicazione in corso. Tutto o una parte. Non c'è burocrazia. Decidi tu quanto cedere e a chi. Questo non è un dettaglio tecnico: è il cuore dell'idea. Il credito diventa moneta di solidarietà concreta, che circola tra le persone come una volta circolava il favore tra vicini.

Il fondo del medico di base. C'è poi un livello più strutturato. Puoi scegliere di donare tutto o parte del tuo credito a un fondo comunitario gestito da Salute Quotidiana. Questo fondo è indirizzato dal medico di base: il medico — che conosce i suoi pazienti, sa chi non riesce a permettersi le cure, sa chi rimanda per motivi economici — indica a Salute Quotidiana chi può beneficiare del fondo. Il paziente fragile riceve la prestazione, il costo viene coperto dal fondo, il medico non gestisce denaro ma indirizza attenzione verso chi ne ha più bisogno.

In questo modo il medico di base entra nel sistema non come erogatore di servizi commerciali, ma come figura di garanzia e orientamento sociale. È il ruolo che dovrebbe sempre avere: il punto di riferimento che conosce la comunità, che sa dove serve aiuto e che adesso ha uno strumento concreto per farlo arrivare.

Il medico di base: terzo polo del sistema

Fin qui il sistema ha due poli: il commercio locale che finanzia e la comunità che beneficia. Ma c'è un terzo polo che trasforma questo programma da iniziativa solidale a modello di sanità di prossimità: il medico di base.

Il GP ha due ruoli simultanei e complementari.

Come clinico di riferimento, il medico conosce i suoi pazienti meglio di chiunque. Sa chi ha una ferita che non guarisce, chi fa analisi di controllo ogni mese, chi ha un presidio sanitario da gestire a casa. Oggi questa conoscenza clinica rimane nella sua testa e il paziente si arrangia da solo. Con SQ, il medico diventa il nodo che trasforma quella conoscenza in accesso concreto: raccomanda Salute Quotidiana al paziente, SQ eroga la prestazione, e il medico riceve un report sintetico sull'intervento eseguito. Il cerchio clinico si chiude. Il paziente non è più seguito da due figure che non fanno l'una dell'altra — è al centro di una rete che coordina.

Come guardiano solidale, il medico indirizza il fondo comunitario — alimentato dalle donazioni di credito dei clienti — verso i pazienti fragili che non hanno mai messo piede al bar aderente e non hanno crediti

accumulati. Sa chi non può permettersi la prestazione. Sa chi rimanda. E adesso ha uno strumento concreto per far arrivare l'aiuto senza che il paziente debba chiederlo o ammetterlo.

Uniti, questi due ruoli fanno del medico di base non un ospite esterno del sistema, ma uno dei suoi architetti. La figura che possiede l'intelligenza clinica del territorio — chi ha bisogno di cosa — e che adesso può convertirla in azione concreta, senza gestire denaro, senza burocrazia aggiuntiva, senza uscire dal suo ruolo professionale.

Il risultato è un ecosistema a tre poli: il **bar** finanzia, la **comunità** accumula e dona, il **medico e l'infermiere** erogano e coordinano. Non è più solo un programma fedeltà con finalità sociale. È un modello di sanità di prossimità finanziato dal commercio locale — che risponde al bisogno dove esiste, con le persone che già ci sono.

Il meccanismo di distribuzione automatica.

Il medico compila una scala clinica validata — come il Barthel Index — per ogni paziente fragile che segnala al sistema. Quella scheda produce un punteggio. Il punteggio viene registrato nell'app e resta lì, aggiornabile nel tempo.

Nel momento in cui un cliente decide di cedere i propri crediti al fondo solidale, l'app non aspetta nessuna decisione umana: calcola istantaneamente la distribuzione proporzionale tra tutti i pazienti beneficiari registrati, in base al loro punteggio clinico. Chi ha un bisogno più grave riceve una quota maggiore. Chi ha un bisogno minore riceve meno. Tutto in tempo reale, nel momento stesso della donazione.

Il medico ha già fatto la sua parte quando ha compilato la scala. L'automazione fa il resto. Nessuna telefonata, nessuna riunione, nessuna decisione arbitraria nel momento critico. La solidarietà funziona da sola, con la stessa velocità con cui un cliente preme "cedi crediti" sull'app.

I numeri del pilot

Per capire se funziona nella realtà — non sulla carta, nella realtà — ho avviato un pilot concreto. Un bar a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un fondo iniziale di 1.000 euro. Un massimo di 20 clienti coinvolti. Durata: 30 giorni.

Ogni cliente può accumulare al massimo 50 euro di Credito SQ — abbastanza per coprire più prestazioni di base in una sola famiglia. Il listino delle prestazioni è quello che uso nella mia attività ordinaria, con prezzi onesti:

Prestazione	Costo
Iniezione intramuscolare	8€
Prelievo periferico	10€
Medicazione semplice	13€
Misurazione parametri base	16€
Prelievo arterioso	20€

Medicazioni complesse	20€
Ulcere ipertrofiche e piede diabetico	20€
Medicazione tracheostomia	30€
Catetere vescicale	35€
Gestione PICC (cateteri venosi centrali)	35€
Sondino naso gastrico	40€
Posizionamento ago di Huber	45€

Servizi diagnostici (disponibili a breve — prezzo SQ scontato del 40% rispetto al mercato privato)

Prestazione	Prezzo di mercato	Prezzo SQ
ECG	50€	30€
Holter ECG 24h	80€	48€
Holter pressorio 24h	70€	42€
Spirometria semplice	50€	30€

Con 50 euro di credito, una famiglia può fare 4-5 prelievi, o 3-4 medicazioni, o un mix di prestazioni che altrimenti avrebbe rimandato di settimana in settimana. Non è un'assicurazione sanitaria. È un accesso concreto, immediato, privo di ostacoli burocratici, a cure che già esistono, già disponibili, già di qualità.

Cosa non è questo progetto

Voglio essere preciso, perché le ambiguità fanno danni.

Salute Quotidiana non sostituisce il medico di base. Non sostituisce il Pronto Soccorso. Non fa diagnosi. Non gestisce emergenze. Per qualsiasi urgenza, la risposta è sempre e senza eccezioni: chiama il 118 o vai al Pronto Soccorso.

Le prestazioni che offro sono programmate, non urgenti. Sono il tipo di cure che una famiglia organizza con un minimo di anticipo: il prelievo per le analisi di controllo, la medicazione di una ferita in fase di guarigione, la gestione di un presidio che richiede competenza infermieristica ma non richiede un ricovero ospedaliero.

Non mi metto in competizione con il Servizio Sanitario Nazionale. Il SSN fa quello che può, con le risorse che ha, spesso con professionalità straordinaria nonostante i tagli che subisce da anni. Io faccio quello che posso, nel territorio dove lavoro, per le persone che conosco di persona.

La tecnologia: semplice ma seria

Ho costruito un'app web. Non perché volessi fare il tecnico, ma perché senza uno strumento digitale il sistema non è gestibile su scala. Carta e penna vanno bene per il primo giorno, non per un programma che vuole crescere e portare dati affidabili.

L'app ha tre ruoli distinti. Il cliente, che vede il suo saldo credito e la sua storia di consumazioni. Il titolare del bar, che vede l'andamento del fondo e le consumazioni aggregate dei suoi clienti. Io, come Salute Quotidiana, che gestisco tutto: registro le prestazioni erogate, valido gli scontrini, tengo la contabilità del fondo in ordine.

Il backend gira su Supabase — un database sicuro, con regole di accesso che garantiscono che ogni utente veda solo quello che gli compete. Il cliente non vede i dati degli altri clienti. Il bar non vede i dettagli delle prestazioni sanitarie di nessuno. La privacy non è una promessa, è strutturale: è scritta nelle regole del database.

Perché ci tengo davvero

Perché ogni volta che vado a casa di una persona anziana che ha rimandato una medicazione per tre settimane perché "costa", mi viene voglia di fare qualcosa che vada oltre quella singola medicazione. Non solo curare quella ferita. Fare qualcosa perché quella situazione non si ripeta, per quella persona e per le altre nella stessa condizione.

Credito Salute SQ non risolve il sistema sanitario italiano. Non abbatte l'ideologia che ha ridotto la salute a voce di costo. Non è una rivoluzione. È una risposta concreta, locale, umana, a un problema reale che vedo ogni giorno con i miei occhi.

È il vicino che aiuta il vicino. Ma con un'app e con la testa.

E inizia da qui, da Francofonte, con un bar e venti persone.